

Dashboard de Efetividade — Roteiro de Apresentação à Diretoria

Documento de apoio para apresentar o sistema tela a tela, explicando cada indicador, cada cálculo e respondendo às dúvidas mais prováveis sobre funcionamento, dados, segurança e atualização.

Como usar: o texto em destaque (" Fala") é o que você pode dizer em voz alta. Os blocos técnicos abaixo de cada fala servem para você responder com segurança se alguém aprofundar.

1. Abertura — o que é o sistema

Fala: "Este é o **Dashboard de Efetividade da Força de Vendas**. Ele transforma os dados brutos de visitação, segmentação, amostras e produtividade dos nossos representantes em **indicadores de gestão prontos para decisão**. Em vez de planilhas dispersas, a liderança passa a ter, em um único lugar, uma visão consolidada — do Brasil inteiro até o setor de um representante específico — e sempre com a possibilidade de filtrar por distrito, setor, ciclo, produto e classificação do médico."

Pontos de valor para reforçar:

- **Uma fonte única de verdade** — todos olham o mesmo número, calculado da mesma forma.
- **Da visão macro à micro** — o mesmo indicador pode ser visto no nível Brasil, Distrito ou Setor.
- **Foco em ação** — o sistema não só mostra o que aconteceu, mas aponta *onde agir* (ex.: médicos de alto potencial sem visita).

O sistema tem 4 telas:

#	Tela	Pergunta de negócio que responde
1	Cobertura e MDV	Estamos visitando o suficiente? Com que intensidade?
2	Visitação x Segmentação	Estamos visitando os médicos certos (os prioritários)?
3	Entrega de Amostras	Estamos distribuindo amostras de forma alinhada à prioridade?
4	Médicos não Visitados	Quem está ficando descoberto e deveria ser visitado?

2. Como o sistema funciona (visão de arquitetura)

Fala: "O sistema é uma aplicação web moderna. O usuário acessa pelo navegador, faz login, e tudo roda de forma segura na nuvem. Os dados ficam em um banco de dados profissional, e a aplicação apenas lê esses dados para calcular os indicadores na hora."

Stack técnica (para quem perguntar):

- **Aplicação web:** Next.js 15 + React 19 (TypeScript). Interface responsiva (funciona em desktop e celular).
- **Gráficos:** biblioteca Recharts.
- **Banco de dados:** PostgreSQL gerenciado pelo Supabase (plataforma de banco de dados na nuvem, baseada em Postgres).
- **Autenticação:** Supabase Auth (login por e-mail e senha).
- **Cálculos pesados:** feitos no próprio banco de dados, via *funções SQL* e *Server Actions* — ou seja, o número chega pronto ao navegador, sem expor a base.

Fluxo dos dados, em uma frase:

Dados de origem → carregados nas tabelas do banco (Supabase) → a aplicação consulta e calcula os KPIs → exibe em cards e gráficos no navegador.

Modelo de dados (organização em “dimensões” e “fatos”):

Tabelas de dimensão (o “cadastro”):

- `dim_medicos` — cadastro de médicos: CRM, nome, classificação, especialidade, **score**, **potencial** (1 a 5) e status (ativo/inativo).
- `dim_hierarquia` — estrutura comercial: setor → representante → distrito → gerente.
- `dim_produtos` — produtos e a qual marca pertencem.
- `dim_calendario` — relação entre datas e ciclos.

Tabelas de fato (os “acontecimentos”):

- `fato_visitas` — cada visita registrada (médico, setor, ciclo, data).
- `fato_segmentacao` — a segmentação de cada médico por marca (PROTEGER, CONQUISTAR, MANTER, OBSERVAR).
- `fato_amstras` — amostras entregues (vinculadas à visita e ao produto).
- `fato_abonos` — horas abonadas por representante e motivo.
- `metas_ciclo` — por setor/ciclo: tamanho do painel, dias trabalhados e se aquele setor deve ser considerado no cálculo.

💡 **Fala simplificada:** “Pense em duas categorias: o **cadastro** (quem são os médicos, qual a estrutura de vendas, quais os produtos) e os **acontecimentos** (quais visitas ocorreram, quais amostras foram entregues). O dashboard cruza essas duas categorias para gerar os indicadores.”

3. Conceitos que aparecem em todas as telas

Vale alinhar **antes** de entrar nas telas, para não repetir:

- **Ciclo:** período de trabalho da força de vendas (ex.: `202604` = 4º ciclo de 2026). Quase todos os indicadores podem ser vistos por um ou vários ciclos.
- **Painel:** conjunto de médicos-alvo de um setor (vem de `metas_ciclo.tamanho_painel`).

- **Segmentação (prioridade do médico):** **PROTEGER** (máxima prioridade) › **CONQUISTAR** › **MANTER** › **OBSERVAR**. Cada médico tem uma segmentação **por marca**.
- **Potencial:** escala de **1 a 5**, onde **1 = maior potencial** de prescrição e **5 = menor**.
- **Filtros globais (topo da tela):** Estrutura (Brasil/Distrito/Setor), Distrito, Setor, Ciclo, Produto e Classificação — conforme a tela. É possível **selecionar vários ciclos** ao mesmo tempo (Ctrl+clique).

4. TELA 1 — Cobertura e MDV (Visão Executiva)

Rota: `/visao-executiva` · **Pergunta:** “Estamos visitando o suficiente e com que intensidade?”

💡 **Fala:** “Esta é a tela de abertura, a visão executiva. No topo temos quatro indicadores de performance, e abaixo a evolução deles ao longo dos ciclos, mais a análise de abonos por representante.”

4.1 Os 4 cards de KPI

① Cobertura de Visitação

- **O que é:** o quanto do painel foi coberto pela visitação.
- **Cálculo:** $\text{total de visitas} \div \text{tamanho do painel} \times 100$.
- Mostra também a **Média Brasil** (para comparar o recorte filtrado com o país) e a **variação vs. ciclo anterior** (em *pontos percentuais*).
- **Meta de referência: 90%** (aparece como linha tracejada no gráfico).

② Média Diária de Visitas (MDV)

- **O que é:** intensidade de visitação — quantas visitas, em média, por dia útil trabalhado.
- **Cálculo:** $\text{total de visitas} \div \text{total de dias trabalhados}$.
- Também traz Média Brasil e variação vs. ciclo anterior. **Meta de referência: 10,8.**

③ Visitas Totais

- **O que é:** o volume absoluto de visitas no período.
- **Cálculo:** contagem de todas as visitas (`fato_visitas`) no recorte selecionado.

④ Visitas Únicas

- **O que é:** quantos **médicos distintos** foram visitados (evita contar o mesmo médico duas vezes).
- **Cálculo:** contagem de CRMs distintos com visita no período.

Sobre as setas de tendência (verde/vermelho): comparam o valor atual com o **ciclo imediatamente anterior**. Se você seleciona o primeiro ciclo da base (sem anterior para comparar), a seta some — proposital, para não exibir comparação inválida.

Detalhe técnico (se perguntarem sobre a Média Brasil): o “Brasil” é recalculado para a **mesma janela de ciclos** selecionada, para a comparação ser justa (mesma régua de tempo no recorte e no país).

4.2 Gráficos de evolução — Cobertura e MDV por estrutura

💡 **Fala:** “Aqui vemos a *evolução*. Cada linha é um distrito (ou setor, se eu detalhar um distrito). A linha vermelha tracejada é a meta. Assim enxergamos tendência: quem está subindo, quem está caindo, quem está acima ou abaixo da meta.”

- **Cobertura por Distrito/Setor:** uma linha por distrito (ou setor), ciclo a ciclo. Meta 90%.
- **MDV por Distrito/Setor:** mesma lógica para a média diária. Meta 10,8.
- **Comportamento inteligente:** se houver **um único ciclo** selecionado, o gráfico vira **barras** (linha com um ponto só não faria sentido).
- Há um botão “**Rótulos**” para exibir/ocultar os valores sobre cada ponto.

4.3 Seção de Abonos (rosca + tabela, sincronizadas)

💡 **Fala:** “Por fim, a análise de abonos — as ausências justificadas. À esquerda, os motivos mais frequentes; à direita, o detalhamento por representante. Os dois respeitam o mesmo filtro de ciclo.”

Gráfico de rosca — Motivos de Abono:

- Agrupa as horas abonadas por **motivo** e mostra os **6 principais**.
- **Conversão:** os abonos são registrados em **horas**; o sistema converte para **dias** dividindo por 8 ($\text{horas} \div 8$). O número no centro é o **total de dias** abonados.

Tabela — Detalhamento por Representante:

- Para cada representante: **dias trabalhados** (soma das metas ativas do período) e **dias abonados** (horas $\div 8$).
- Representantes sem meta ativa no período são marcados como desconsiderados.
- Tem paginação (12 por página).

5. TELA 2 — Visitação x Segmentação

Rota: `/visitacao-x-segmentacao` · **Pergunta:** “Estamos visitando os médicos *certos*?”

💡 **Fala:** “Cobertura alta é bom, mas não basta visitar muito — temos que visitar os médicos **prioritários**. Esta tela cruza a visitação com a segmentação, por produto.”

5.1 Os 5 cards de Potencial

- Cinco cards, um para cada nível de **potencial (1 a 5)**.
- Cada card mostra o **% de médicos do painel** naquele nível (e o número absoluto no canto).
- **Cálculo:** $\text{médicos no nível N} \div \text{total de médicos do painel} \times 100$.
- Respeita os filtros de **território e classificação**. Como potencial é uma característica fixa do médico, **não depende do ciclo**.

💡 **Fala:** “Isso mostra a *qualidade do nosso painel*: quanto dele é de alto potencial.”

5.2 As 6 tabelas por produto

Uma tabela para cada marca: **Família Regenesis, Slinda, Gynotran, Gynpro, Hemolip e Vizuria.**

Cada tabela quebra os médicos por segmentação (PROTEGER, CONQUISTAR, MANTER, OBSERVAR, SEM SEGMENTAÇÃO) e mostra:

- **Visitados:** quantos médicos daquela segmentação foram visitados no ciclo (número e % sobre o total).
- **Não Visitados:** o complemento.
- **Total Geral** no rodapé.

💡 **Fala:** “O que eu quero ver aqui é a coluna *Visitados* alta nas linhas **PROTEGER** e **CONQUISTAR** — são os médicos que mais importam para aquela marca. Se a cobertura dos PROTEGER está baixa, é um alerta de direcionamento.”

6. TELA 3 — Entrega de Amostras

Rota: `/alocacao-de-recursos` · **Pergunta:** “As amostras estão indo para quem tem prioridade?”

💡 **Fala:** “Amostra é investimento. Esta tela mostra para onde esse investimento está indo — por segmentação e por classificação do médico.”

6.1 Os 3 cards de KPI

① **Total de Médicos** — médicos únicos ativos no painel (respeita o território filtrado).

② **Média Geral de Amostras**

- **Cálculo:** `total de amostras entregues ÷ total de médicos do painel`.
- Usa o painel como denominador para não distorcer (um médico que aparece em várias marcas é contado uma vez só).

③ **Total de Amostras Entregues** — soma de todas as unidades de amostra entregues (`fato_amostras.quantidade`) no período.

6.2 Os 2 gráficos (barras + linha)

Ambos combinam **barras** (nº de médicos) com uma **linha** (média de amostras por médico):

- **Por Segmentação:** distribui médicos e amostras entre PROTEGER/CONQUISTAR/MANTER/OBSERVAR. A segmentação é determinada pela **marca do produto efetivamente entregue**.
- **Por Classificação Médica:** mesma análise, mas quebrada pela classificação do médico.

💡 **Fala:** “Quero ver a **linha de média de amostras mais alta nos segmentos prioritários**. Se estamos entregando muita amostra em OBSERVAR e pouca em PROTEGER, há um desalinhamento entre o investimento e a estratégia.”

7. TELA 4 — Médicos não Visitados (Target List)

Rota: `/target-list` · **Pergunta:** “Quem está descoberto e precisa de ação?”

💡 **Fala:** “Esta é a tela mais acionável. Ela lista os médicos **ativos que ficaram sem visita nos últimos 3 ciclos** — a nossa lista de recuperação.”

Definição de “não visitado” (critério do sistema):

- Médico **ativo**;
- **sem nenhuma visita** nos **3 ciclos mais recentes**;
- e que **não** tenha sido **incluído** no painel nesses últimos 3 ciclos (para não penalizar médicos recém-cadastrados).

7.1 Os 4 cards de KPI

① **Total sem Visita** — quantidade de médicos na lista.

② **Médicos não Visitados (Taxa de Abandono)**

- **Cálculo:** `não visitados ÷ total de médicos ativos do território × 100`.
- Mostra também os números absolutos (“X de Y médicos no painel”).

③ **Alto Potencial Não Visitado** — médicos da lista com **potencial 1 ou 2**. São a prioridade de recuperação.

④ **Multi-marca Não Visitado** — médicos da lista com segmentação ativa em **3 ou mais marcas**. Alvos estratégicos de portfólio.

7.2 A tabela e a exportação

- Lista cada médico com **CRM, especialidade, a segmentação em cada uma das 6 marcas, Score Exeltis e Potencial**.
- **Ordenável** por qualquer coluna, com **busca** por nome/CRM.
- **Botão “Exportar”**: gera um arquivo **Excel (.xlsx)** com a lista filtrada — pronto para distribuir aos representantes como plano de ação.

💡 **Fala:** “Na prática, o gestor filtra o distrito dele, ordena por potencial, exporta o Excel e manda para a equipe. Vira plano de visita imediato.”

8. Perguntas prováveis da diretoria (Q&A preparado)

Sobre os DADOS

“**De onde vêm os dados?**” Dos sistemas de origem da força de vendas (registros de visita, segmentação, amostras, metas e produtividade). Esses dados são carregados nas tabelas do banco de dados na nuvem (Supabase/PostgreSQL), e o dashboard os consome para calcular os indicadores.

“Com que frequência os dados são atualizados?” O dashboard sempre exibe **o que está no banco no momento do acesso** — não há defasagem entre o banco e a tela. A **carga** dos dados é feita a cada **3 semanas**, acompanhando o ciclo da força de vendas, garantindo que cada ciclo fechado esteja refletido no painel.

 *Roadmap: a atualização é hoje conduzida manualmente pela área responsável. Está prevista a construção de um **script de ETL** para automatizar essa carga, reduzindo esforço operacional e o risco de erro manual.*

“Os números são confiáveis? Como sei que o cálculo está certo?” Cada indicador tem uma **fórmula única e centralizada** — o mesmo cálculo vale para todas as telas e todos os usuários. As regras estão descritas neste documento e implementadas em funções no banco de dados, o que elimina divergência de planilhas. Cada card tem ainda um **ícone de ajuda (?)** que explica sua fórmula na própria tela.

“Posso confiar no histórico? O dado de um ciclo passado muda?” Os ciclos fechados refletem o que foi registrado. Indicadores como potencial e segmentação refletem o **cadastro atual** do médico (são características vigentes, não “fotografias” do passado) — vale deixar isso claro ao analisar séries longas.

Sobre SEGURANÇA

“Quem pode acessar o sistema?” Apenas usuários **com login e senha** criados por nós. Não há cadastro aberto: as contas são provisionadas manualmente pela administração do sistema.

“Como funciona o login?” Autenticação via **Supabase Auth**, padrão de mercado. As senhas **não são armazenadas em texto** — ficam criptografadas (hash) na plataforma. A sessão do usuário é protegida por token.

“Os dados trafegam de forma segura?” Sim. Toda a comunicação é via **HTTPS** (criptografada em trânsito). O banco fica na infraestrutura gerenciada do Supabase, que oferece criptografia e backups.

“Um representante consegue ver os dados de outro distrito?” Sim — e isso é **intencional**. A liderança definiu que a visão deve ser **transparente e compartilhada**: todos os usuários autorizados enxergam todos os territórios. Isso favorece o *benchmarking* entre distritos e uma cultura de comparação saudável. O controle de acesso é por **login** (só entra quem é autorizado), mas, uma vez dentro, a base é visível por completo.

Caso no futuro se queira segmentar o acesso por território, a arquitetura permite (perfis de acesso / RLS) — mas hoje, por decisão de negócio, o acesso é amplo.

“E se um funcionário sair?” A conta é **desativada/removida** em segundos no painel administrativo, cortando o acesso imediatamente.

Sobre FUNCIONAMENTO e MANUTENÇÃO

“Onde isso roda? Precisa instalar algo?” Não. É **100% web** — basta o navegador e o login. Roda na nuvem; não há instalação na máquina do usuário.

“E se cair? Tem backup?” O banco fica em uma plataforma gerenciada (Supabase) com **backups automáticos**. A aplicação é hospedada em infraestrutura de nuvem escalável.

“Quanto custa manter?” Os custos são de **infraestrutura de nuvem** (banco/hospedagem) e do serviço de e-mail transacional para o login — todos com planos previsíveis e escaláveis conforme o uso.

“Dá para adicionar novas telas / indicadores?” Sim. A arquitetura é modular: novos indicadores, filtros e telas podem ser adicionados sem refazer o que existe. Distritos, setores, produtos e ciclos novos aparecem **automaticamente** nos filtros assim que entram na base.

“Funciona no celular?” Sim, a interface é responsiva e se adapta a telas menores.

Sobre EVOLUÇÃO (mostrar visão de futuro)

Possíveis próximos passos que você pode antecipar como roadmap:

- **Script de ETL** para automatizar a carga de dados (hoje feita manualmente a cada 3 semanas).
- **Autoatendimento de senha** (recuperação por e-mail) e/ou login corporativo único (SSO).
- Novos indicadores conforme a necessidade da diretoria.

9. Roteiro rápido (colar “na ponta da língua”)

1. **Abertura:** “Fonte única de verdade para a efetividade da força de vendas, do Brasil ao setor.”
2. **Tela 1 – Cobertura e MDV:** estamos visitando o suficiente (cobertura, meta 90%) e com que intensidade (MDV, meta 10,8); evolução por ciclo; abonos.
3. **Tela 2 – Visitação x Segmentação:** estamos visitando os médicos certos? Qualidade do painel (potencial) + cobertura por prioridade, produto a produto.
4. **Tela 3 – Entrega de Amostras:** o investimento em amostra está alinhado à prioridade?
5. **Tela 4 – Médicos não Visitados:** lista acionável de recuperação, exportável em Excel.
6. **Fechamento:** “Dados seguros na nuvem, login controlado, cálculos centralizados e auditáveis, e arquitetura pronta para evoluir.”

Anexo — Tabela-resumo dos cálculos

Indicador	Tela	Fórmula
Cobertura de Visitação	1	$\text{total de visitas} \div \text{tamanho do painel} \times 100$ (meta 90%)
MDV	1	$\text{total de visitas} \div \text{dias trabalhados}$ (meta 10,8)
Visitas Totais	1	contagem de todas as visitas no período
Visitas Únicas	1	contagem de médicos (CRM) distintos visitados
Dias Abonados	1	$\text{horas abonadas} \div 8$
% por Potencial	2	$\text{médicos no nível N} \div \text{total do painel} \times 100$
% Visitados (segmentação)	2	$\text{médicos visitados} \div \text{total da segmentação} \times 100$
Média Geral de Amostras	3	$\text{total de amostras} \div \text{total de médicos do painel}$
Total de Amostras	3	soma das quantidades entregues
Taxa de Abandono	4	$\text{não visitados (3 ciclos)} \div \text{ativos do território} \times 100$
Alto Potencial Não Visitado	4	nº de não visitados com potencial 1 ou 2
Multi-marca Não Visitado	4	nº de não visitados com segmentação em 3+ marcas